

±mc = 48,44

NS			
Mário Sergio dos Santos (Wellington Pherix)			
IDADE: 38	PESO: 145	ALTURA: 165	PROFISSÃO: Motorista Corretor
SINTOMAS: sonolência diurna / cansaço / pernas inchadas			
QUEIXAS: esposa relata que ele fica engasgado.			
MEDICAMENTOS: Exforge HCT. - Xarope (esta c/ tosse)			
MÉDICO: Dra Barbara Coimbra / Dr. Sérgio			
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 00:00 - 1:00		HORA QUE ACORDA: 5h	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM (X) NA SEMANA () NÃO (F. Sm.) (cachorro)			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim Nasal		BANHEIRO: 3x a 4x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV (++)	IAH: 129.2	SPO2: 57% -
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hernia Inguinal na (+20a.)			
CIRURGIAS: (N) NASAL (M) MAMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim - não sabe			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDOCRINA (S) CARDÍACA HAS			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
Quando caminhava sente dor. / SN 22211840257			
12/01/24 - Avaliação. / DN 664			
CPAP automático 6-14 cmH ₂ O, rampa deslig. / humidif. G.			
06/01 24	P = 12 max. / 6 cmH ₂ O (min)	IAH = 1.3 e/ev	
m. de uso: 5h44'		Duq cláudia	
não vai ao banheiro mais, sonolência diurna acabou.			
20/03 24	P = 11.5 cmH ₂ O	Relata melhora da	
IAH = 1.0 e/ev		sonolência diurna	
m. de uso: 5h42'		fria	
Fuga = 19.6 epm			
23/09 24	P = 8.1 cmH ₂ O	melhora da sonolência	
IAH = 1.0 e/ev			
m. de uso: 5h51'		Duq cláudia	
Fuga = 5.9 epm			
30/04 25	P = 8.2 cmH ₂ O	- oriento sobre	
IAH = 1.1		o uso do	
Fuga = 7.0 epm		CPAP, manter constante	
P = 8.0 - 10.4		ao	
IAH = 1.1 e/ev		- Dormir de lado	
m. de uso: 4h58			

- ↓ o peso 120kg.

Biologix IDO = 14.

fria

Nome: MARIO SERGIO DOS SANTOS

Data de Nascimento: 4-5-1985

IMC: 48,44

Sexo: Masculino

Data do exame: 24-10-2023

Peso: 140 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DRA. BARBARA COIMBRA PORTO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 24-10-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 567,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 67,5 minutos. O tempo total de sono foi de 480,5 min, eficiência de 84,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 74,1%; estágio N3: 5,0%; sono REM: 18,7%. O índice de despertares foi de 90,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 129,2/hora, sendo 147 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 392 hipopnéias. A SpO2 média foi de 86% e a mínima de 57%, permanecendo 48,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 92 bpm e NREM de 43 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (18), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 129,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=57%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (7,1/hora);
9. registro de ronco durante o sono;

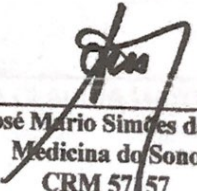
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57